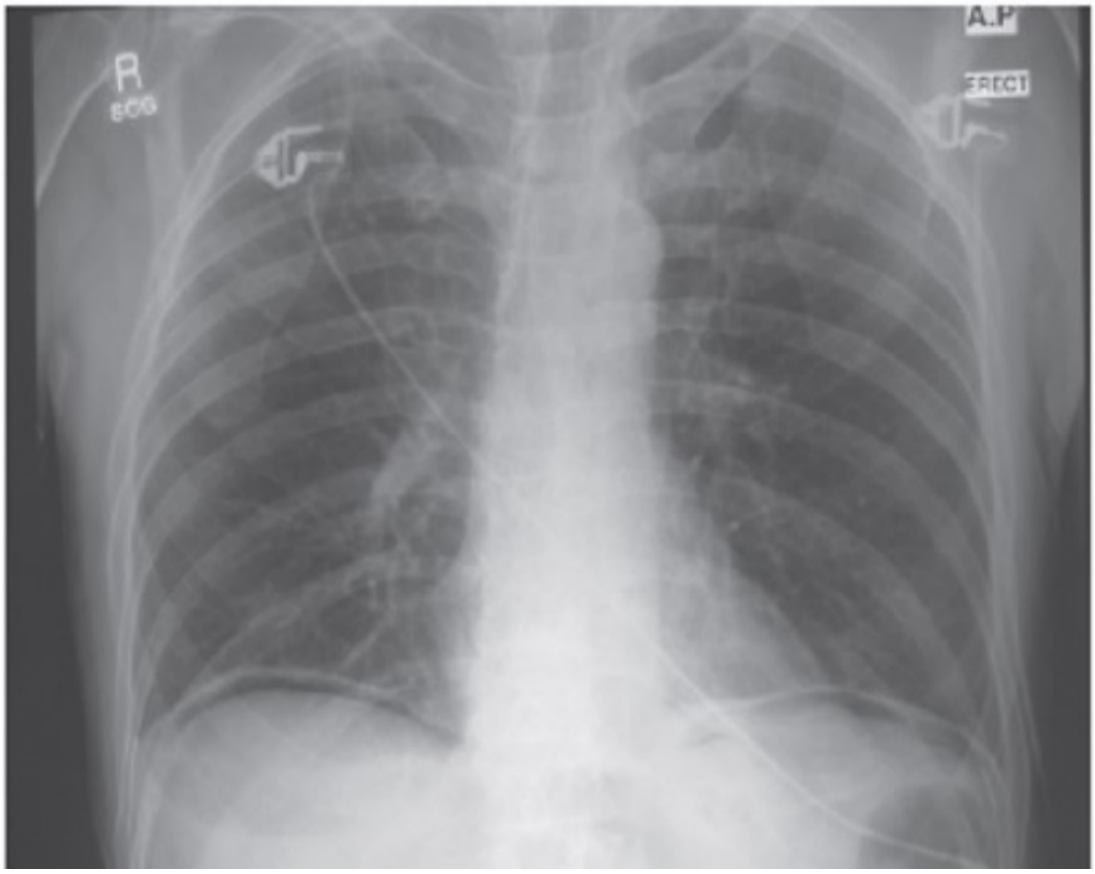
09. 급성 복통

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 17문항 · 정답 · 해설판

2025년 시험 2번 · 출제자 박지연

1. 38세 남자가 2시간 전부터 윗배가 아파서 응급실에 왔다. 통증이 매우 심하면서 시간이 지날수록 더 심해지고, 예전에는 이렇게 아픈 적이 없었다고 한다. 처음에는 명치부위가 불편하였고 기침을 하거나 걸을 때 통증이 심해졌다고 한다. 평소 속쓰린 증상이 있어서 가끔씩 위장약을 복용하고 있다고 하고, 평소 하루 한갑의 흡연 및 주 5회 소주 1병 이상의 음주력이 있다. 혈압 145/80 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 25회/분, 체온 38.1도이다. 호흡음과 심음은 정상이다. 배는 약간 팽만되어 있고, 장음은 잘 들리지 않는다. 배 전체가 판자처럼 단단하고 압통과 반발압통이 심하다. 흉부 엑스선 촬영 및 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 적절한 조치는?

혈액: 혈색소 16.2 g/dL, 백혈구 18,840/ mm³ (중성구 85%), 혈소판 250,000/mm³



① 응급수술
② 혈관조영술
③ 입원하여 경과 관찰
④ 진통제 처방 후 퇴원
⑤ 복부초음파 유도 하 경피적 배액술

> **정답 ①**
> 속쓰림 병력이 있는 흡연 · 음주자가 갑자기 시작해 점점 심해지는 상복부 통증, 판자처럼 단단한 배(복막 자극), 장음 감소, 발열 · 빈맥 · 백혈구 증가를 보이므로 소화성궤양 천공에 의한 범발성 복막염이다. 흉부 X선에서 횡격막 아래 유리공기(기복증)가 보이면 확인된다. 범발성 복막염을 동반한 천공은 응급수술(천공 봉합 등)이 원칙이다.

2. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4℃ 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /mm³, 혈소판 205,000/mm³
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② **복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.**
③ 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

정답 ②

식후 시작된 우상복부 통증이 오른쪽 어깨로 방사되고, 발열, 우상복부 압박 시 숨을 들이쉬지 못하는 Murphy 징후가 있으며 과거에도 비슷한 담도산통이 있었으므로 급성 담낭염이다. 담낭염 진단의 첫 영상검사는 복부 초음파(담석, 담낭벽 비후, 담낭 주위 액체, 초음파 Murphy 징후)다. 단순 복부촬영은 담석 대부분이 보이지 않아 확진이 어렵고, 저절로 좋아졌던 병력이 있어도 경과 관찰만 하면 안 된다.

3. 54세 남자가 어제부터 발생한 복부 팽만 및 배꼽 주위의 경련통으로 왔다. 어제부터 변을 보지 못했고 가스를 배출한 기억이 없으며, 오늘은 담즙 섞인 구토를 두차례 하였다. 4년 전에 위암으로 위전절제술을 받은 것 이외 특이 과거력은 없다. 혈압은 110/85 mmHg - 맥박수 90회/분 - 호흡수 22회/분 - 체온 37.1도였으며, 진찰 결과 복부는 약간 팽만되어 있었으나 경직이나 반발통은 없었다. 단순 복부 촬영 소견이 아래 사진과 같다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 구토로 인한 탈수가 있을 것으로 판단되므로 충분한 경구 수분 섭취를 권장한다.

② 비위관 삽입이 증상 완화에 도움이 된다.

③ 정확한 진찰 및 진단을 위해 통증 조절을 가급적 보류한다.

④ 혈액검사 결과 이상소견이 없다면 퇴원을 고려한다.

⑤ 청진시 장음이 소실되면 호전된 상태라고 판단할 수 있다.

> **정답 ②**
>
> 위전절제술 후 유착으로 생긴 소장 폐쇄다: 배꼽 주위 경련성 복통, 복부팽만, 배변 · 가스 배출 중단, 담즙성 구토와 단순 촬영의 확장된 소장 고리 · 공기-액체층. 비위관을 넣어 위장관을 감압하면 구토와 팽만이 줄고 흡인 방지에도 도움이 된다. 금식과 정맥 수액이 필요하며(경구 섭취 금지), 통증 조절은 진단을 방해하지 않으므로 보류하지 않는다. 장음이 사라지는 것은 교액 · 장마비 등 악화를 시사한다.

2024년

2024년 시험 23번 · 출제자 박지연

4. 78세 남자 환자가 복부 통증 및 이와 동반된 오심, 오한으로 왔다. 약 3일전부터 식후 더부룩함이 있어 소화제를 간헐적으로 복용했다고 하며, 내원 하루 전부터는 통증이 우하복부에 심하게 느껴지면서 걷기가 불편했다고 한다. 평소 고혈압으로 치료 중이며, 5년 전에 위암으로 위하부절제술을 받은 적이 있다. 혈압 130/75 mmHg, 맥박 91회/분, 호흡 22회/분, 체온 33.5°C이다. 신체진찰 결과 장음이 감소되어 있으며, 우하복부에 저명한 압통과 반발통이 있다. 혈액 검사 결과 및 복부 X-ray 사진은 아래와 같다. 다음 필요한 검사로 가장 적절한 것은?

혈색소 10.1 g/dL, 백혈구 13,300/mm³ (중성구 90.7%), 혈소판 148,000/mm³

AST (aspartate transaminase) 35 U/L (참고치, ≤37)

ALT (Alanine transaminase) 31 U/L (참고치, ≤41)

총 빌리루빈 1.48 mg/dL (참고치 0.20 ~ 1.10)

Amylase 42 U/L (참고치, 30~118)

Lipase 19 U/L (참고치 12~53)



① 위내시경

② 대장내시경

③ 내시경 역행담췌관조영술

④ 배변조영술

⑤ 복부 컴퓨터단층촬영

정답 ⑤

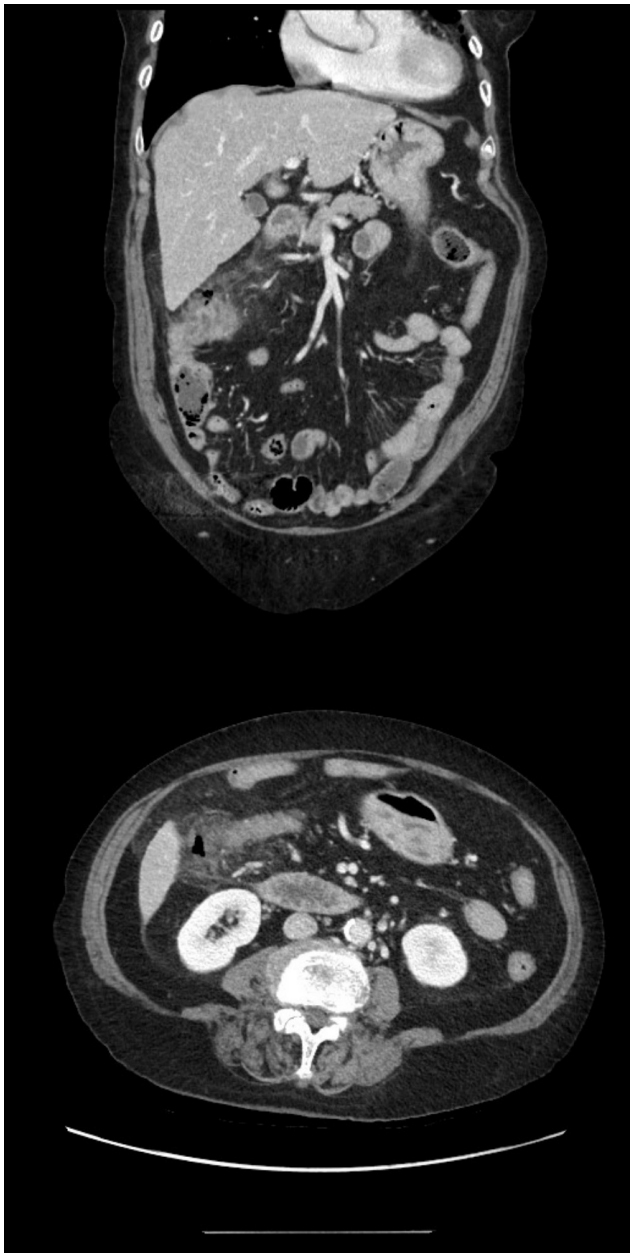
위절제술 병력이 있는 고령 환자의 식후 불편감 후 우하복부로 국한된 심한 압통 · 반발통, 장음 감소, 백혈구 증가(중성구 90%)는 급성 충수염(천공 가능성 포함) 같은 국소 복막염을 시사한다. 고령자는 증상이 비전형적이고 원인이 다양하므로(충수염, 게실염, 종양 천공, 장폐색 등) 복부 CT가 진단과 합병증 평가에 가장 적절하다. 내시경 · 배변조영술은 급성 복막염 상황에서 적절하지 않다.

2023년 담당 송승호

2023년 시험 17번

5. 78세 여자가 3시간 전부터 배가 아파서 응급실에 왔다. 1일 전 검진 목적으로 대장내시경 검사를 받았고, 결장 전반에 걸쳐 10개의 용종을 내시경적 점막절제술로 제거하였다고 한다. 내시경 검사 이후 복부 불편감이 있었으나 심하지 않았다고 하며, 3시간 전부터 갑자기 구역질이 나고 배가 아프다고 한다. 혈압 180/92 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.5 ℃ 이다. 배는 팽만되어 있고, 전체적으로 압통과 반동압통이 있다. 복벽은 강직되어 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진(사진1,2)이다. 조치는?

백혈구 19,500/mm³, 혈색소 8.5 g/dL, 혈소판 95,000/mm³, C-반응단백질 15.1 mg/dL (참고치, < 0.50)



① 경과 관찰

② **응급 수술**

③ 경피적배액술

④ 식도위내시경

⑤ 복강동맥조영술

> **정답 ②**
>
> 대장내시경으로 용종 여러 개를 점막절제한 다음 날 갑자기 생긴 복통, 발열 · 빈맥, 배 전체의 압통 · 반동압통 · 복벽 강직(범발성 복막염)과 CT상 복강 내 유리공기는 대장 천공이다. 범발성 복막염을 동반한 천공은 응급수술이 필요하다. 경과 관찰이나 경피적 배액술은 국소적이고 작은 천공에서 증상이 경미할 때만 고려한다.

2023년 시험 45번

6. 25세 남자가 갑자기 배가 아프다며 응급실에 왔다. 평소 불규칙하게 식사를 하고 5년째 매일 1갑 이상 담배를 핀다고 한다. 혈압 110/62 mmHg, 맥박 99회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.6 ℃ 이다. 명치 주변으로 압통이 있고 반동압통은 명확하지 않다. 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 검사는?

백혈구 13,500/mm^3, 혈색소 16.5 g/dL, 혈소판 225,000/mm^3, 혈액요소질소/크레아티닌 19/0.9 mg/dL, C-반응단백질 3.1 mg/dL (참고치, < 0.50)

① 대장내시경

② 복부초음파

③ 식도위내시경

④ **가슴 및 복부 X선**

⑤ 복부골반 컴퓨터단층촬영

> **정답 ④**
>
> 불규칙한 식사와 흡연을 하는 젊은 남자가 갑자기 명치 통증을 호소하므로 소화성궤양과 그 천공을 먼저 의심한다. 가장 먼저 할 검사는 선 자세의 가슴 X선과 복부 X선으로 횡격막 아래 유리공기를 확인하는 것이다(빠르고 간단). 천공이 의심될 때 내시경은 금기에 가깝고, CT는 X선에서 애매할 때 추가한다.

7. 52세 남자가 배가 불러진다고 병원에 왔다. 소량의 대변을 자주 보고, 변을 볼 때는 복통이 있다고 한다. 혈압 110/62 mmHg, 맥박 101회/분, 호흡 29회/분, 체온 38.1 ℃ 이다. 하복부에 반동압통이 있다. 직장손가락검사에서 덩이가 만져지지 않았다. 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 검사는?

백혈구 21,500/mm^3, 혈색소 8.5 g/dL, 혈소판 125,000/mm^3, 혈액요소질소/크레아티닌 19/0.9 mg/dL, C-반응단백질 5.1 mg/dL (참고치, < 0.50), 암배아항원 11.0 ng/mL

① 대장내시경
② 식도위내시경
③ 복부동맥조영술
④ ^{99m}Tc-DISIDA 스캔
⑤ **복부골반 컴퓨터단층촬영**

정답 ⑤

배변 습관 변화(소량의 잦은 변, 배변 시 복통), 빈혈, CEA 상승은 대장암을 시사하고, 발열 · 빈맥 · 하복부 반동압통 · 백혈구 증가는 천공이나 농양 같은 합병증을 시사한다. 복막염이 의심되는 상황에서는 대장내시경이 금기이므로, 원인과 합병증(천공 · 농양 · 폐쇄)을 함께 평가할 수 있는 복부골반 CT를 먼저 시행한다.

8. 57세 남자가 배가 아파서 응급실에 왔다. 2일 전부터 구역질이 나기 시작했고, 구토를 여러 차례 했다고 한다. 15년 전 복막염으로 개복술을 받았다고 한다. 혈압 80/58 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 22회/분, 체온 39.1℃ 이다. 배는 팽만되어 있고, 전체적으로 반동압통이 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 배 X선 사진(사진1)이다. 조치는?

백혈구 19,500/mm³, 혈색소 10.5 g/dL, 혈소판 95,000/mm³, C-반응단백질 15.1 mg/dL (참고치, < 0.50)



① 경과 관찰
② 응급 수술
③ 대장내시경
④ 경피적배액술
⑤ 식도위내시경

정답 ②

개복술 병력이 있는 환자의 구토, 복부팽만(장 폐쇄를 시사하는 X선), 그리고 저혈압 · 빈맥 · 고열 · 범발성 반동압통 · 백혈구 증가 · CRP 상승은 교액성 장폐색(장 괴사)이나 천공에 의한 복막염과 패혈성 쇼크를 시사한다. 수액 소생과 항생제를 시작하면서 응급수술을 해야 한다. 대장내시경 · 경피적 배액술 · 경과 관찰은 적절하지 않다.

2022년

2022년 시험 24번

9. 32세 여자가 하루 전부터 배가 아파서 응급실에 왔다. 전날 저녁 과식한 후 명치 주위가 아프기 시작하면서 메슥거리고 여러 차례 토했다고 하며 시간이 지나면서 점점 아랫배가 아프다고 한다. 혈압 148/95 mmHg, 맥박수 95회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5 도 이다. 오른쪽 아랫배에 압통과 반동압통이 있다. 혈액 및 소변 검사는 다음과 같다. 이 환자의 진단에 가장 도움이 되는 검사는?

혈액: 혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 15,770/mm³, 혈소판 421,000/mm³
소변: 잠혈 (-), glucose (-), 백혈구 (-), 단백질 (-), 잠혈 (-), hCG (-)

① 질경유초음파촬영
② **복부컴퓨터단층촬영**
③ 복부자기공명영상
④ 위내시경
⑤ 대장내시경

> **정답 ②**
> 명치 주위 통증으로 시작해 구역 · 구토가 있고 시간이 지나 오른쪽 아랫배로 옮겨 가며 압통 · 반동압통, 백혈구 증가를 보이는 것은 전형적인 급성 충수염이다. 가임기 여성이지만 hCG 음성으로 자궁외임신이 배제되었고 소변검사도 정상이다. 성인에서 충수염을 확진하고 천공 · 농양 등을 평가하는 데 가장 도움이 되는 검사는 복부 CT다(임신부 · 소아는 초음파를 우선 고려).

10. 34세 남자가 심한 우측 옆구리와 우하복부 통증으로 왔다. 통증은 3시간 전에 갑자기 시작되어 점점 심해졌다. 내원 당시 통증으로 인하여 가만히 누워있지 못하는 상태로 통증 강도는 점수 10점중 10점 정도로 매우 심하였으나 진통제 주사 투여 후 8점 정도로 감소하였다. 통증 발생 후 2차례의 구토가 동반되었으며, 그 외 흉통이나 호흡곤란, 소화불량, 발열 등의 증상은 없었다. 혈압은 154/96 mmHg, 맥박수 79 회/분, 호흡수 24 회/분, 체온 36.7℃ 였다. 신체 검사 결과 우하복부에 압통이 있었으며 반발통은 없었고, 그 외 신체검진 상 이상 소견은 없었다. 혈액 및 소변 검사 결과 아래와 같다. 위 환자에서 가능성이 높은 진단은 무엇인가?

혈색소 15.6 g/dL, 백혈구수 8,030/mm³, 혈소판 205,000/mm³

AST (aspartate transaminase) 26 U/L (참고치, ≤37)

ALT (Alanine transaminase) 32 U/L (참고치, ≤41)

Total bilirubin 0.98 mg/dL (0.3~ 1.2)

소변 검사 : 잠혈 (3+), 단백질 (+), 적혈구 many/고배율시야, 백혈구 0~2/고배율시야

① Acute appendicitis (급성막창자꼬리염)

② acute cholecystitis (급성쓸개염)

③ peptic ulcer perforation (궤양천공)

④ acute pancreatitis (급성이자염)

⑤ urolithiasis (요로결석)

정답 ⑤

갑자기 시작된 극심한 옆구리~아랫배 통증으로 가만히 있지 못하고 구토가 동반되며, 복막 자극 징후(반발통) 없이 소변에서 현미경적 혈뇨(적혈구 다수)가 보이므로 요로결석(요관결석)이다. 충수염 · 담낭염 · 천공 · 췌장염 같은 복막 염증 질환은 환자가 움직이지 않으려 하고 발열 · 백혈구 증가 · 복막 자극 징후를 보이는 경우가 많다.

11. 79세 남자가 7일 전 경구약제 복용 후 목에 무언가 걸린 것 같은 이물감, 불편감이 있던 중 2일 전부터는 복통이 발생하여 점차 통증이 심해져서 왔다. 복통 발생 후 검은변을 두차례 봤다고 한다. 뇌졸중 및 치매 병력이 있으며, 만성신부전으로 주 3일 투석 중이다. 혈압 92/41 mmHg - 심박수 110 회/분 - 호흡수 22회/분 - 체온 37.6℃이다. 환자는 가만히 누워 움직이지 않으려고 하며, 진찰 시 복부 전반에 걸쳐 압통, 반발통이 심하다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 다음 중 옳은 것은?

혈색소 10.2 g/dL, 백혈구 15,100 /mm³ (중성구 91.8%), 혈소판 91,000 / mm³
C-reactive protein 32.21 mg/dL (참고치 < 0.30)
Sodium 131 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 3.0 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 109 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 0.97 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아스파르테이트아미노전달효소 83 U/L (참고치, <35)
알라닌아미노전달효소 37 U/L (참고치, 10 - 49)

① 탈수 증상이 있을 것으로 생각되므로 경구 수분섭취를 권장한다.
② 오진의 위험이 있으므로 확진 전까지 통증 조절은 보류한다.
③ 관장이 증상 완화에 도움이 될 것이다.
④ 복부 컴퓨터단층촬영이 진단에 유용하다.
⑤ 대장내시경 검사를 통해 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.

정답 ④

약을 먹은 뒤 목에 무언가 걸린 느낌이 있다가 복통이 생겼으므로 삼킨 이물(약 포장지(PTP) 등)에 의한 위장관 천공 · 출혈을 의심한다. 흑색변, 저혈압 · 빈맥, 복부 전반의 압통 · 반발통, 백혈구 · CRP 상승은 복막염과 패혈증을 시사한다. 복부 CT로 이물의 위치, 천공 부위, 유리공기를 확인하는 것이 진단에 유용하다. 경구 섭취 · 관장 · 대장내시경은 금기이고 통증 조절을 보류할 필요는 없다.

2021년

2021년 시험 31번

12. 38세 남자가 5시간전부터 왼쪽 옆구리가 아파서 왔다. 통증이 심할 때는 메스꺼우면서 구토도 동반된다고 한다. 혈압 130/85 mm/Hg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.3℃ 이다. 왼쪽 갈비척추각에 압통이 있다. 혈액 및 소변 검사 결과와 복부 X 선 사진이다. 진단은?

혈액:
혈색소 14.4 g/dL, 백혈구 8,030/mm^3, 혈소판 320,000/mm^3
혈액요소질소/크레아티닌 16/0.8 mg/dL,
$Na^+/K^+/Cl^-$ 138/4.0/104 mEq/L
소변:
적혈구 다수/고배율시야, 백혈구 1~5/고배율시야



① **요관돌**
② 방광염
③ 만성쓸개염
④ 구불결장염전
⑤ 잘록창자곁주머니염

> **정답 ①**
> 갑자기 생긴 한쪽 옆구리 통증(구역 · 구토 동반), 같은 쪽 갈비척추각 압통, 발열 · 백혈구 증가 없이 소변의 적혈구 다수(혈뇨), 복부 X선의 요관 경로를 따라 보이는 방사선 비투과성 음영은 요관결석이다. 방광염은 배뇨통 · 빈뇨와 농뇨, 쓸개염은 우상복부 통증, 구불결장 염전은 심한 복부팽만이 특징이다.

13. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4℃ 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

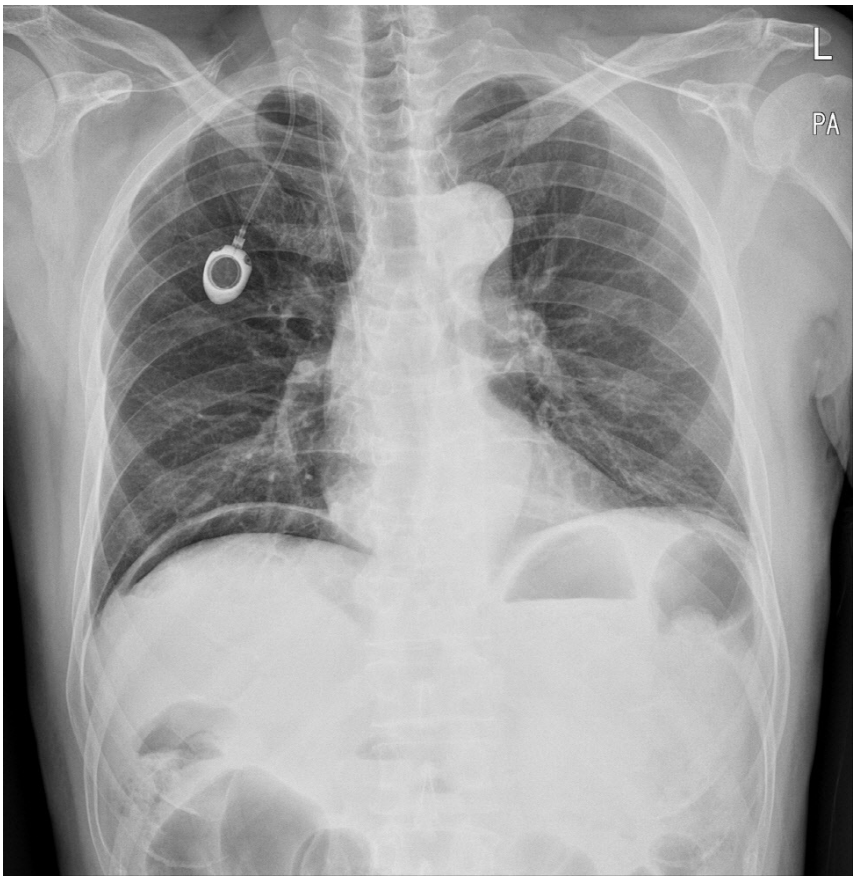
혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /mm³, 혈소판 205,000/mm³
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17 U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
③ **복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.**
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

> **정답 ③**
> 식후 시작된 우상복부 통증이 오른쪽 어깨로 방사되고, 발열, Murphy 징후(우상복부 압박 시 흡기 정지), 과거 반복된 담도산통이 있어 급성 담낭염이다. 첫 영상검사는 복부 초음파로 담석, 담낭벽 비후, 담낭 주위 액체를 확인한다. 단순 복부촬영은 담석 대부분이 보이지 않아 확진할 수 없고, 상부내시경은 담낭 질환을 진단하지 못한다.

14. 65세 남자가 5시간 전부터 시작된 심한 복통으로 응급실에 왔다. 복막 전이를 동반한 위암으로 9개월 전부터 고식적 항암화학요법 중이며 그 동안 특별한 부작용은 없었다고 한다. 위암 외 다른 동반 질환은 없으며, 혈압 131/94 mmHg - 심박수 94회/분 - 호흡수 20회/분 - 체온 37.9도°C이다. 진찰 시 불수의적인 복부 강직을 보이고 복부 전반에 걸쳐 압통이 있었으며, 특히 상복부의 압통과 반발통이 심했다. 혈액 검사 및 흉부X-ray 결과는 아래와 같다. 이 환자에 대한 설명으로 적절한 것은?

혈색소 11.4 g/dL, 백혈구 12,100 /mm³, 혈소판 244,000 / mm³
Sodium 136 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 4.7 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 109 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 0.83 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아스파르테이트아미노전달효소 19 U/L (참고치, <35)
알라닌아미노전달효소 15 U/L (참고치, 10 - 49)



① 전이성 위암으로 인한 통증으로 항암화학요법을 지속한다.
② 위내시경 검사를 시행하여 위암을 재평가 한다.
③ 복수 천자가 증상 완화에 도움이 된다.
④ **복부 컴퓨터 단층 촬영이 치료 방법 결정에 도움이 된다.**
⑤ 말기암 환자이므로 진통제 처방 후 경과 관찰하는 것이 최선이다.

정답 ④

복막 전이가 있는 위암으로 항암치료 중인 환자에게 갑자기 심한 복통과 불수의적 복부 강직(판자 복부), 상복부 반발통이 생겼으므로 위암 부위 천공에 의한 복막염을 의심해야 한다(흉부 X선에서 유리공기 확인). 말기 암 환자라도 천공 여부와 범위를 복부 CT로 평가해야 수술 · 보존적 치료 등 치료 방침을 정할 수 있다. 항암치료 지속, 내시경, 단순 진통제 처방은 적절하지 않다.

2020년

2020년 시험 57번

15. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4℃ 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /mm³, 혈소판 205,000/mm³
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17 U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
③ **복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.**
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

> **정답 ③**
> 식후 시작된 우상복부 통증이 오른쪽 어깨로 방사되고, 발열, Murphy 징후(우상복부 압박 시 흡기 정지), 과거 반복된 담도산통이 있어 급성 담낭염이다. 첫 영상검사는 복부 초음파로 담석, 담낭벽 비후, 담낭 주위 액체를 확인한다. 단순 복부촬영은 담석 대부분이 보이지 않아 확진할 수 없고, 상부내시경은 담낭 질환을 진단하지 못한다.

16. 73세 남자환자가 복부 통증 및 이와 동반된 복부팽만, 오심, 구토로 왔다. 약 2주전부터 간헐적 복통과 함께 배변이 잘 안되었다고 하며 어제 오후부터는 가스 배출이 전혀 안되면서 더욱 통증이 심해졌다고 한다. 고혈압 외에 다른 기저 질환은 없었으며, 혈압 110/75 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.3°C이다. 진찰 시 복부팽만이 있었으나 압통이나 반발통은 저명하지 않았다. 혈액 검사 결과 및 복부 X-ray 사진은 아래와 같다. 다음 필요한 검사로 가장 적절한 것은?

혈색소 9.6 g/dL, 백혈구 7,800/mm³, 혈소판 185,000/mm³

AST (aspartate transaminase) 35 U/L (참고치, ≤37)

ALT (Alanine transaminase) 25U/L (참고치, ≤41)



① 복부 초음파
② 위내시경
③ 복막천자술
④ 배변조영술
⑤ 복부 컴퓨터 단층 촬영

정답 ⑤

2주간 서서히 진행한 배변 장애 후 가스 배출이 완전히 멈추고 복부팽만이 심해졌으며, 빈혈(혈색소 9.6)이 있고 X선에서 장 확장 소견이 있으므로 대장암 등에 의한 대장 폐쇄를 의심한다. 폐쇄의 위치 · 원인(종양, 염전 등)과 천공 · 허혈 같은 합병증을 확인하는 데는 복부 CT가 가장 적절하다. 폐쇄 상태에서 배변조영술은 부적절하고, 복부 초음파는 장 가스 때문에 평가가 어렵다.

17. 63세 남자 환자가 어제부터 지속된 심한 명치 부위 통증과 오심으로 왔다. 내원 직전 2차례 구토를 하였다. 통증은 등쪽으로 번지는 양상이라고 한다. 환자는 고혈압, 당뇨병 과거력이 있으며, 지난 약 20여년간 거의 매일 소주 2병 이상의 음주력 및 한 갑 이상의 흡연력이 있다. 혈압 90/60 mmHg - 심박수 110 회/분 - 호흡수 28 회/분 - 체온 38.5도 였으며, 신체 검진 상 복부 팽만이 있었으며, 상복부의 압통을 보였으나 반발통은 없었다. 심전도는 정상 소견이었으며, 혈액검사 및 복부단층촬영 소견은 아래와 같다. 가장 가능성이 높은 진단은?

혈색소 14.5 g/dL
백혈구 5,100 /mm³
혈소판 280,000 / mm³
Sodium 133 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 3.5 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 98 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 1.0 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아밀라제 160 U/L (참고치 22 - 80)
리파아제 880 U/L (참고치 0 - 60)



① acute dissection (대동맥박리)
② acute cholecystitis (급성쓸개염)
③ peptic ulcer perforation (궤양천공)
④ acute pancreatitis (급성췌장염)
⑤ acute mesenteric ischemia (급성장간막허혈)

정답 ④

오랜 과음 후 등으로 퍼지는 심한 명치 통증, 구토, 발열 · 빈맥 · 저혈압과 함께 리파아제가 정상 상한의 3배 이상(880 U/L)으로 올라가 있고 CT에서 췌장 부종 · 주위 염증이 보이므로 급성 췌장염이다(진단 기준 3가지 중 2가지 이상 충족). 대동맥박리는 찢어지는 흉통 · 맥박 차이, 궤양 천공은 판자 복부와 유리공기, 담낭염은 우상복부 통증과 Murphy 징후가 특징이다.